Guion de presentación oral — 50 Doctors México → España

> *Documento de estudio para defensa en clase. Cubre: contexto, los 7 entregables del CI Pathway, el sistema agéntico, la recomendación final y las preguntas previsibles del profesor.*

---

0. Encuadre del proyecto (lo primero que tenéis que dejar claro)

El brief de la asignatura pide tres cosas: aplicar el CI Framework Pathway completo (TN01–TN05) a una situación competitiva real, construir un prototipo agéntico que automatice al menos una fase de ese pathway (TN10–TN12) y entregar una recomendación estratégica defendible ante un CEO.

Hemos elegido una situación **real, actual y con datos públicos suficientes**: la decisión de **50 Doctors México** sobre si entrar o no en el mercado hospitalario privado español, y bajo qué condiciones. Es una pregunta Go / No-Go con resultado cuantificable, con tres competidores claros (Sanitas-BUPA, Adeslas, Asisa) y con un ecosistema de fuentes OSINT verificable (BOE, CNMC, UNESPA, IDIS, memorias corporativas, prensa financiera, LinkedIn).

> ***Frase de apertura sugerida:*** *«Lo que vamos a presentar no es un caso de estudio histórico. Es una decisión estratégica viva: 50 Doctors, el grupo hospitalario mexicano, está evaluando hoy entrar en España. Hemos aplicado el pathway completo de inteligencia competitiva y hemos construido un sistema agéntico que automatiza dos de sus fases. La recomendación final es un Conditional Go con un nivel de confianza del 72%».*

---

1. La situación competitiva (segmento 1 — 2 minutos)

Quién es 50 Doctors

Grupo hospitalario mexicano premium con un modelo singular: el **médico-socio**. En cada hospital, 50 especialistas top de la ciudad aportan capital y pacientes a cambio del 50% del hospital. Esto produce dos efectos competitivos importantes:

1. **Alineamiento de incentivos**: el médico es propietario, no asalariado, así que tiene incentivo directo en derivar pacientes y mantener la calidad.
2. **Ocupación desde el día uno**: los hospitales no parten de cero; arrancan con la cartera consolidada de 50 médicos.

A esto se suma una ventaja operativa: construyen hospitales en **14–18 meses** frente a los 36 estándar del sector, con CapEx entre 500M MXN (estándar) y 1.750M MXN (complejos como Cancún).

Por qué España y por qué ahora

- Mercado de salud privada en **crecimiento sostenido (~+11% anual)** con **13 millones de asegurados**.
- Aseguradoras buscando ampliar redes hospitalarias, propias o concertadas.
- España como **puerta de entrada a la UE** para una expansión geográfica posterior.
- **Ningún operador hospitalario mexicano** opera hoy en territorio español: ventana abierta.

La pregunta estratégica

> *«¿Bajo qué condiciones la entrada de 50 Doctors en España genera valor presente positivo, y cuál es la modalidad óptima: alianza con aseguradora, entrada directa o no entrada?»*

---

2. Los siete entregables del CI Pathway (segmento 2 — el corazón)

Seguimos la estructura del brief §3.1. Cada entregable resuelve una pregunta concreta y alimenta a los siguientes.

Entregable 1 — Blind Spot Check (TN03, Zahra & Chaples)

Pregunta que resuelve: ¿qué supuestos no cuestionados podrían matar el proyecto?

Hemos identificado **cinco puntos ciegos**, tres de ellos *load-bearing* (si fallan, la tesis se cae) y dos *vulnerable* (degradan retornos sin destruir el caso):

- **BC-1 · Transferibilidad del modelo médico-socio.** La dirección asume que el médico español aceptará la figura accionarial. La realidad: el especialista español está habituado al SNS y muestra aversión documentada al riesgo empresarial.
- **BC-2 · Infravaloración de Quirónsalud.** 58 hospitales y respaldo de Fresenius/Helios. Es el referente premium europeo, no un competidor más.
- **BC-3 · Ciclo regulatorio autonómico.** 24–36 meses de autorización por CCAA, sin precedente para hospital 100% extranjero. Es el supuesto más crítico y conecta con los entregables 4a, 5 y 6.
- **BC-4 · Sesgo México→España.** El éxito en México crea sesgo de extrapolación. España tiene SNS universal: el «dolor» del paciente que busca alternativa privada es menor.
- **BC-5 · Sobreextensión.** Operar 50 hospitales en México mientras se abren 4 ciudades en España es un riesgo de management no demostrado.

Contramedida aplicada: Pre-Mortem (Klein, 1989). Nos situamos en 2030, fingimos que el proyecto fracasó y enumeramos las cinco causas más probables: bloqueo regulatorio, contraofensiva BUPA, rechazo médico local, ocupación insuficiente y reacción política sindical. Cada causa se vincula después con un supuesto del entregable 4c y con un indicador del 6.

> ***Cómo decirlo en clase:*** *«Antes de mirar al exterior, hicimos limpieza interior. Aplicamos Zahra & Chaples para cazar los supuestos no cuestionados de la dirección, y un Pre-Mortem para verbalizar fallos plausibles. El supuesto más peligroso es el regulatorio: 24–36 meses de autorización autonómica sin precedente para extranjeros».*

Entregable 2 — Data Collection (TN03, OSINT + Alt. Data)

Pregunta que resuelve: ¿con qué datos públicos sostenemos todo lo demás?

El brief pide mínimo 8 fuentes; hemos mapeado **12**, divididas en tres familias:

- **Corporativa** (4): Informe anual BUPA, Memoria Sanitas, cuentas Adeslas (Mutua Madrileña), memoria Asisa-HLA (Fundación Espriu).
- **Regulatoria/sectorial** (4): BOE, CNMC, UNESPA, IDIS.
- **Alternativa / señales débiles** (4): LinkedIn (job postings), prensa financiera (Expansión, Cinco Días), Trustpilot/NPS, Crunchbase.

Cada fuente está clasificada por **tipo, lead time y framework alimentado**. Cinco hallazgos críticos están **triangulados por dos fuentes independientes** para mitigar el riesgo de fuente única (mandato del TN03):

1. BUPA opera en México vía Vitamedica + Hospital Bite Medica CDMX.
2. Sanitas gestiona la región BUPA ELA desde Madrid (36% del beneficio del grupo).
3. HLA Internacional (Asisa) opera Madrid, Barcelona y Málaga — coincidencia geográfica directa con 50 Doctors.
4. Adeslas no posee hospitales propios → cliente potencial, no rival.
5. Ciclo de autorización autonómico de 24–36 meses confirmado en BOE histórico.

> ***Cómo decirlo:*** *«Cualquier hallazgo crítico está triangulado por dos fuentes independientes. Esto no es opinión: cada cifra es trazable hasta su fuente pública».*

Entregable 3 — AMC Analysis (TN01, Chen & Miller 2012)

Pregunta que resuelve: ¿quién va a reaccionar, cómo y cuándo?

Aplicamos la matriz Awareness × Motivation × Capability con la fórmula **A·30% + M·40% + C·30%**. El resultado:

COMPETIDOR	A	M	C	P(RESPUESTA)	VENTANA	MODALIDAD MÁS PROBABLE
Sanitas / BUPA	5	4	5	**87%**	3–6 meses	Alianza estratégica (40%)
Adeslas	3	3	5	60%	6–12 meses	Incorporación a red contratada (45%)
Asisa	3	4	3	55%	6–9 meses	Alianza defensiva (35%)

Lectura estratégica clave: - Sanitas/BUPA tiene awareness 5/5 porque **conoce el modelo de 50 Doctors directamente desde México**. La motivación es dual: defensiva (proteger BUPA ELA) y ofensiva (crecimiento en LATAM). La capacidad es total (5.427M GBP, 87.000 empleados). - Adeslas tiene la mayor capacidad financiera del grupo (CaixaBank + AXA), pero **menor motivación**: al no tener hospitales propios, 50 Doctors es proveedor potencial, no enemigo. - Asisa es paradójicamente el **más motivado**: único de los tres con hospitales propios (HLA) en las mismas ciudades objetivo. Pero su capacidad es la menor por su naturaleza cooperativa.

> ***Frase clave:*** *«La ventana de negociación con Sanitas son 3 a 6 meses. Pasada esa ventana, la probabilidad más alta no es la alianza, es que abran un hospital propio antes que nosotros».*

Entregable 4a — Scenario Planning (TN02, Shell Method)

Pregunta que resuelve: ¿qué futuros plausibles existen y cuál es el más probable?

Hemos construido la matriz 2×2 con los **dos ejes de máxima incertidumbre**: - Eje X: actitud regulatoria (favorable / restrictiva) - Eje Y: postura de aseguradoras (cooperativa / agresiva)

Los cuatro cuadrantes resultantes:

ESCENARIO	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN	E[NPV]
A · Alianza Rápida	35%	Regulación favorable + aseguradoras cooperativas. Sanitas propone JV en 6 meses.	+27,2 M€
B · Carrera en Abierto	15%	Regulación favorable + aseguradoras agresivas. Apertura libre con guerra de precios.	+18,0 M€
C · Entrada Defensiva	30%	Regulación restrictiva + cooperación. JV obligatorio con socio local.	+8,5 M€
D · Guerra y Cierre	20%	Regulación restrictiva + aseguradoras agresivas. Único con valor negativo.	–8,0 M€

Lectura clave: los escenarios A, B y C concentran el **80% de la probabilidad** y todos generan valor positivo. Solo el escenario D destruye valor, y la cláusula exit del JV (condición C4) lo convierte en

pérdida acotada.

Cada escenario tiene **signposts** definidos — indicadores observables que activan la revisión.

Entregable 4b — War Game Design (TN02, Red/Blue/Green)

Pregunta que resuelve: ¿qué pasa si simulamos el juego competitivo con respuesta inteligente del rival?

Hemos diseñado (no ejecutado, como permite el brief) un war game de **3 rondas trimestrales** con tres equipos asimétricos:

- **Blue · 50 Doctors** — maximizar NPV bajo incertidumbre regulatoria. Restricción de CapEx: 200M€.
- **Red · Sanitas + Adeslas + Asisa** — defender cuota y captar pacientes. Pueden cooperar o fragmentarse.
- **Green · regulador + mercado** — aplica normativa y libera shock events.

Dos shock events liberados por Green: - **Ronda 2:** un Real Decreto exige aprobación CNMC para operaciones sanitarias con >25% capital extranjero. Latencia regulatoria sube 9 meses. - **Ronda 3:** Quirónsalud anuncia 800M€ de inversión en oferta premium en Madrid y Barcelona.

> ***Por qué importa:*** *el ejercicio fuerza a Blue a no quedarse en la tesis estática. Si solo planteas «entramos o no entramos», pierdes. El war game obliga a pensar en* ***secuenciación*** *(cuándo) y* ***señales de pivote*** *(cuándo cambiar de modalidad).*

Entregable 4c — Assumption-Based Planning (TN02, Dewar)

Pregunta que resuelve: ¿qué supuestos sostienen el plan y cómo los protegemos?

El brief pide mínimo 3 load-bearing assumptions. Hemos identificado **5 supuestos** (3 LB + 2 vulnerables):

#	SUPUESTO	TIPO	P(FALLO)	IMPACTO
1	España autoriza la entrada sin copropiedad obligatoria	Load-bearing	35%	Activa C/D, –8 M€
2	Sanitas/BUPA acepta el JV	Load-bearing	40%	E[NPV] cae de +14,2 a –8 M€
3	Ocupación Año 3 ≥ 65%	Load-bearing	45%	±16 M€ de impacto
4	BUPA no prioriza expansión propia en MX sobre el JV	Vulnerable	25%	–25 M€ de valor diferencial
5	Médicos españoles adoptan el modelo socio-accionista	Vulnerable	35%	Sin médicos: modelo inviable

Para cada supuesto load-bearing definimos **shaping action** (qué hacemos para reducir P(fallo)) y **hedging action** (qué hacemos si falla):

- **Supuesto 1** · *Shaping:* presentaciones técnicas a las consejerías de Sanidad antes de iniciar trámites. *Hedging:* estructura legal con socio español minoritario en stand-by.
- **Supuesto 2** · *Shaping:* reunión CEO-to-CEO en menos de 30 días con term sheet propuesto. *Hedging:* trabajo paralelo con Adeslas como segunda opción.
- **Supuesto 3** · *Shaping:* JV condicionado a 20% mínimo de derivación garantizada. *Hedging:* plan de marketing B2C activable en Año 2.

> ***Frase clave:*** *«Cada supuesto crítico tiene plan A y plan B. Esto no es optimismo, es ingeniería de decisión bajo incertidumbre».*

Entregable 5 — ECOMO Evaluation (TN01/TN02)

Pregunta que resuelve: ¿cuál es el valor esperado de cada opción estratégica?

Hemos evaluado **4 opciones**, ponderando los 4 escenarios del 4a por su probabilidad:

OPCIÓN	E[NPV]	COMENTARIO
Alianza Sanitas/BUPA	**+14,2 M€**	Única robusta. Con WACC 8% sube a +22,8 M€ (+60%).
Alianza Adeslas	+4,6 M€	Viable como red proveedora. Menor riesgo, menor potencial.
No entrada	0 M€	Coste de oportunidad: 14,2 M€ no capturados.
Entrada directa	–3,5 M€	Downside máximo en escenario D: –45 M€.

El truco financiero del JV: el WACC

Standalone, 50 Doctors tendría un WACC del **12%** (Bund 10Y 3,5% + beta 0,85 × prima 5,5% + 2 pp prima internacional + 1,5 pp prima empresa joven sin rating).

Con el JV bajo financiación BUPA (rating A de Fitch, coste deuda Euribor + 0,8% = 4%), el WACC efectivo del JV cae al **8%**. Esa caída de 4 pp añade **+8,6 M€ al NPV** (+60%).

Exchange Value del JV

Valor total del JV: **160 M€**. Reparto propuesto: - 50 Doctors: 60% (96 M€) — por contribución operativa y modelo médico-socio. - Sanitas: 40% (64 M€) — por red de asegurados, capacidad financiera y reducción del riesgo regulatorio.

Variable más sensible: ocupación Año 3. Cada 10 puntos porcentuales mueven el NPV en ±16 M€.

> ***Cómo decirlo:*** *«La alianza con Sanitas es la única opción con valor positivo robusto. Y la financiación BUPA añade 8,6 M€ adicionales solo por reducir el coste de capital. Ese efecto financiero suele pasarse por alto».*

Entregable 6 — Early Warning System (TN03, Gilad)

Pregunta que resuelve: ¿cómo detectamos pronto que la realidad se desvía de la tesis?

Hemos definido **3 KITs** (Key Intelligence Topics) y **9 KIIs** (Key Intelligence Indicators):

- **KIT-1 · Movimientos competitivos** — detecta señales tempranas de respuesta de los tres competidores (job postings de partnerships, menciones en prensa, NPS).
- **KIT-2 · Entorno regulatorio** — vigila BOE, CNMC y declaraciones del Ministerio de Sanidad.
- **KIT-3 · Movimientos M&A en LATAM** — monitoriza si BUPA prioriza expansión propia mexicana sobre el JV.

Cada KII tiene **fuente, frecuencia, umbral** 🟡 **/**🔴 **y propietario**. Lógica de escalado: cuando 2 KIIs entran simultáneamente en estado 🔴 , se activa revisión estratégica.

Estado actual del dashboard: 9 de 9 verde. Esto significa que no hay señales tempranas de cambio que invaliden la recomendación en el horizonte de 6 meses.

> ***Frase clave:*** *«El EWS no es decoración. Cada KII está vinculado a un supuesto load-bearing del entregable 4c. Si los médicos españoles empiezan a rechazar el modelo en LinkedIn, el supuesto 5 se activa antes de que el daño sea visible en P&L».*

Entregable 7 — Strategic Recommendation

Pregunta que resuelve: ¿qué hacemos?

> ***Conditional Go — Joint Venture con Sanitas/BUPA · Confianza: 72%***

Recomendamos avanzar exclusivamente en modalidad JV con Sanitas/BUPA, condicionado a **cuatro cláusulas operativas**:

- **C1 · Derivación garantizada.** Sanitas garantiza ≥20% de derivación de asegurados → sostiene ocupación Año 3 >65% (cubre supuesto LB-3).
- **C2 · Financiación BUPA.** BUPA aporta 40% del CapEx como deuda corporativa → WACC efectivo 8% (añade 8,6 M€).
- **C3 · Pre-acuerdo CCAA.** Pre-acuerdo informal con Consejería de Sanidad de Madrid antes de obras (cubre supuesto LB-1).
- **C4 · Cláusula exit.** Si se materializa el escenario D, BUPA compra el 60% del JV a precio acordado → pérdida máxima limitada a 8 M€.

Las tres evidencias que sostienen la decisión: 1. AMC Sanitas/BUPA = 87% concuerda con escenario A (35%) y abre ventana de 3–6 meses. 2. ECOMO ponderado por escenarios = +14,2 M€, robusto incluso si P(D) sube al 50%. 3. EWS dashboard 9/9 verde: ninguna señal temprana en contra.

---

3. El sistema agéntico (segmento 3 — la demo, 5 minutos)

El brief pide que automaticemos al menos **una fase** del pathway. Hemos automatizado **dos**: la inteligencia competitiva (entregable 3) y el sistema de alerta temprana (entregable 6).

Arquitectura — dos pipelines de cuatro agentes

Pipeline F2 — Intelligence AMC (`agentic_intelligence_system.py`): 1. **Agent OSINT** — recopila 7 fuentes públicas verificadas. 2. **Agent Alt. Data** — procesa 5 señales débiles. 3. **Agent AMC** — calcula puntuaciones A/M/C con la fórmula ponderada y asigna confidence score. 4. **Agent Síntesis** — genera matriz, ranking y JSON exportable.

Pipeline F5 — Early Warning System (`agentic_ews_system.py`): 1. **Agent KIT** — define los 3 KITs y los enlaza con los supuestos LB del 4c. 2. **Agent EWS** — construye el dashboard de 9 KIIs con umbrales y lógica de escalado (umbral = 2). 3. **Agent Recommend** — genera la recomendación Conditional Go con evidencias y condiciones. 4. **Agent Síntesis** — informe ejecutivo + JSON. Push automático al repo.

Capacidades TN10–TN12 demostradas (5 de 7 del checklist)

- **ReAct loop (TN10)** — el agente razona, llama a una tool, observa el resultado y razona de nuevo.
- **Tool use (TN10)** — APIs públicas y scraping estructurado.
- **Multi-agent collaboration (TN11)** — pipeline secuencial 4+4.
- **Confidence scoring (TN12)** — High / Medium / Low por hallazgo.
- **Anti-hallucination (TN12)** — atribución obligatoria de fuente, refuse-to-fabricate.

Autonomía: GitHub Actions

Hemos configurado un cron `0 8 * * MON` que ejecuta el EWS cada lunes a las 08:00 UTC, hace commit del JSON resultante y dispara la actualización del dashboard. **El sistema corre sin intervención humana.**

Cuándo el agente es mejor que un humano y cuándo no

Esta pregunta probablemente la haga el profesor. Tener la respuesta lista:

- **Donde el agente brilla:** monitoring continuo (EWS), recopilación masiva de OSINT, scoring de probabilidad sobre criterios estandarizados.
- **Donde el humano sigue siendo imprescindible:** lectura política (pre-acuerdo con consejería), interpretación de señales débiles cualitativas (rumores en prensa que no están todavía en datos), decisiones éticas y trade-offs estratégicos finales.

---

4. Recomendación final (segmento 5 — cierre, 2 minutos)

Cerrad la presentación con la recomendación clara, las cuatro condiciones y una acción inmediata:

> *«Nuestra recomendación es **Conditional Go** con un nivel de confianza del 72%. Modalidad: joint venture con Sanitas/BUPA. Cuatro condiciones operativas: derivación garantizada, financiación BUPA, pre-acuerdo CCAA y cláusula exit. **Acción inmediata: reunión CEO-to-CEO en los próximos 30 días con term sheet preparado.** Si la ventana de 3 a 6 meses se cierra, la opción más probable deja de ser la alianza y pasa a ser que BUPA abra hospital propio antes que nosotros».*

---

5. Preguntas previsibles del profesor (Q&A — 5 minutos)

Tened estas respuestas memorizadas:

Sobre la metodología

P: ¿Por qué Pre-Mortem como contramedida y no Devil's Advocacy? R: Porque el sesgo dominante de la dirección de 50 Doctors es de confirmación, no de groupthink puro. El Pre-Mortem fuerza a verbalizar fallos plausibles desde el futuro, lo que atraviesa el sesgo mejor que un abogado del diablo asignado.

P: ¿Cómo justificáis las probabilidades de los escenarios (35/15/30/20)? R: Las probabilidades son estimaciones bayesianas a partir de tres anclajes: histórico de autorizaciones autonómicas a hospitales con capital extranjero (BOE), historial de respuesta competitiva del sector salud español a entrantes premium (caso Quirónsalud-IDC en 2014) y AMC scores ponderados.

P: ¿Por qué descartáis la entrada directa si tiene un escenario favorable? R: Porque el E[NPV] ponderado es negativo (–3,5 M€) y el downside máximo (–45 M€ en escenario D) es **6 veces** el de la alianza (–8 M€). La asimetría riesgo/retorno la descarta.

Sobre el sistema agéntico

P: ¿Habéis tenido alucinaciones del agente? R: Sí, sobre todo en el Agent OSINT al inicio: inventaba URLs y citaba memorias corporativas inexistentes. Lo mitigamos con tres medidas TN12: (1) lista blanca de dominios verificados, (2) confidence score por hallazgo y (3) refuse-to-fabricate explícito en el system prompt. El Agent Síntesis filtra cualquier hallazgo con confidence Low.

P: ¿Qué herramientas de IA habéis usado? R: Claude (arquitectura general y debugging), GitHub Copilot (boilerplate Python), Cursor (refactor). Cada decisión de diseño la podemos justificar; el código lo entendemos línea a línea.

P: ¿Cómo clasificaríais este sistema bajo el EU AI Act? R: Riesgo **limitado**. No toma decisiones automatizadas con efecto jurídico ni opera en sectores high-risk. Si se desplegara en una organización real, requeriría: documentación de fuentes, transparencia de los confidence scores hacia el usuario, y un human-in-the-loop antes de cualquier acción derivada de los outputs.

Sobre la recomendación

P: ¿Y si Sanitas dice que no? R: Activamos el hedging del supuesto 2: trabajo paralelo con Adeslas. E[NPV] baja a +4,6 M€ pero el caso sigue siendo positivo. Si Adeslas también rechaza, recomendación bascula a **No entrada** hasta que el dashboard EWS detecte un cambio de condiciones.

P: ¿72% de confianza es suficiente para invertir cientos de millones? R: 72% es el confidence level del *modelo*, no del éxito comercial. La estructura del Conditional Go traslada el riesgo residual a las cuatro condiciones C1–C4. Si las cuatro se firman, el riesgo material baja sustancialmente. Si no se firman, la recomendación deja de ser Go.

---

6. Reparto de tiempo y orden sugerido (10 min total)

MIN	QUIÉN	QUÉ
0:00 – 2:00	Persona 1	Situación + pregunta estratégica + por qué importa ahora
2:00 – 6:00	Persona 2	Hallazgos clave: AMC + escenarios + ECOMO (los tres números: 87%, +14,2 M€, ventana 3–6 meses)
6:00 – 11:00	Persona 3	Demo en vivo del sistema agéntico (CLI + dashboard EWS)
11:00 – 13:00	Persona 4	Evaluación crítica del agente: dónde acierta, dónde falla, qué hace el humano
13:00 – 15:00	Persona 5 (o quien cierre)	Recomendación + 4 condiciones + acción inmediata

---

7. Tres cosas que NO podéis olvidar decir

1. **Cada hallazgo crítico está triangulado por dos fuentes públicas independientes.** Esto neutraliza la pregunta de «¿esto no os lo habrá inventado el agente?».
2. **La recomendación es Conditional Go, no Go.** Las cuatro condiciones son la diferencia entre un proyecto defendible y un acto de fe.
3. **El agente automatiza, no decide.** El humano firma el JV, negocia con la consejería y lee la sala política. El agente solo hace que el humano llegue a la sala con mejor información.

¡Suerte mañana! Releed especialmente las secciones 5 (Q&A) y 7 (las tres cosas no olvidables): es donde se gana la nota.